

1. TRATAMIENTO INDICADO

Diagnóstico principal: diabetes mellitus secundaria diabetes mellitus tipo 1 o 2 diabetes mellitus embarazo

Codificación del diagnóstico (CIE-9): 249.___ 250.___ 648.___

Indicación principal: especificar las condiciones de financiación

FÁRMACOS DE ADMINISTRACIÓN ORAL

ATC	Fármaco	Posología	Condiciones de financiación	Observaciones
Antidiabéticos orales monofármaco				
A10BG03	Pioglitazona	15 mg/24 h 30 mg/24 h	Pioglitazona está indicada para el tratamiento de la DM2: En monoterapia: en pacientes, particularmente aquellos con sobrepeso, en los que no se logra un control adecuado con dieta y ejercicio y que no pueden recibir metformina por contraindicaciones o intolerancia. En doble terapia oral, en combinación con las siguientes sulfonilureas: clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, glipizida, gliquidona, glisentida y tolbutamida. Solo en pacientes que presentan intolerancia a la metformina o en los que la metformina esté contraindicada, y en los que no se logra un control glucémico adecuado independientemente de la dosis máxima tolerada de sulfonilurea en monoterapia. Pioglitazona también está indicada en combinación con insulina para el tratamiento de pacientes con DM2 en los que el tratamiento con insulina no permite un control glucémico adecuado, y en los que no es apropiado el uso de metformina debido a contraindicaciones o intolerancia. Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses después para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reducción en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los médicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.	Se requiere tratamiento previo con metformina.
A10BJ06	Semaglutida	3 mg/24 h 7 mg/24 h 14 mg/24 h	Para el tratamiento de la DM2 en personas obesas con un IMC igual o mayor de 30Kg/m ² y en terapia combinada con otros antidiabéticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando éstos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado.	Se requiere cálculo previo del IMC.
A10BK02	Canagliflozina	300 mg/24 h	Tratamiento de aquellos pacientes diabéticos que con la dosis de 100 mg de canagliflozina no alcanzan el control glucémico.	Se requiere tratamiento previo con canagliflozina de 100mg.

Antidiabéticos orales en combinación				
A10BD16	Canagliflozina/ metformina	150 mg + 850 mg/24 h 150 mg + 1000 mg/24 h	Tratamiento de aquellos pacientes diabéticos que con la dosis de 50mg/850mg o 50mg/1000mg de canagliflozina/metformina no alcanzan el control glucémico.	Se requiere tratamiento previo con dosis de 50 mg/850 mg o 50 mg/1000 mg.
A10BD06	Glimepirida/ pioglitazona	30 mg + 2 mg/24 h 30 mg + 4 mg/24 h	Está indicado para el tratamiento de pacientes con DM2 que sufren intolerancia a la metformina o en quienes la metformina está contraindicada y que están ya en tratamiento con una combinación de pioglitazona y glimepirida.	Se requiere tratamiento previo y estable con ambos fármacos por separado.
A10BD19	Linagliptina/ empagliflozina	10 mg + 5 mg/24 h 25 mg + 5 mg/24 h	Pacientes que estén en tratamiento con linagliptina y empagliflozina por separado después de haber comprobado que responden adecuadamente a los dos antidiabéticos sin asociar, es decir en aquellos en los que el tratamiento está estabilizado y es efectivo.	Se requiere tratamiento previo y estable con ambos fármacos por separado.
A10BD05	Pioglitazona/ metformina	15 mg + 850 mg/12 h	Competact está indicado en el tratamiento de pacientes con DM2, especialmente pacientes con sobrepeso, que no alcanzan el control glucémico suficiente con la dosis máxima tolerada de metformina oral en monoterapia. Glubrava está indicado en el tratamiento de pacientes con DM2, especialmente pacientes con sobrepeso, que no alcanzan el control glucémico suficiente con la dosis máxima tolerada de metformina oral en monoterapia. Pioglitazona/metformina Aristo 15 mg/850 mg: tratamiento de segunda elección de pacientes adultos con DM2, especialmente pacientes con sobrepeso, que no alcanzan el control glucémico suficiente con la dosis máxima tolerada de metformina oral en monoterapia. Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes entre 3 y 6 meses después para evaluar la respuesta al tratamiento (por ej. reducción en HbA1c). En los pacientes que no muestren una respuesta adecuada, se debe interrumpir el tratamiento con pioglitazona. Considerando los riesgos potenciales del tratamiento prolongado, los médicos deben confirmar en las subsiguientes revisiones rutinarias que se mantiene el beneficio de pioglitazona.	Requiere tratamiento previo con metformina.

Abreviaturas utilizadas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de masa corporal; HbA1c: hemoglobina glicosilada.

FÁRMACOS DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA				
ATC	Fármaco	Posología	Condiciones de financiación	Observaciones
Antidiabéticos de administración semanal				
A10BJ05	Dulaglutida	0,75 mg 1,5 mg	Tratamiento de la DM2 en obesos con un IMC igual o mayor de 30Kg/m ² y en terapia combinada con otros antidiabéticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando éstos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado.	Se requiere cálculo previo del IMC.
A10BJ01	Exenatida	2 mg	Bydureon está indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con DM2 para mejorar el control glucémico en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina basal, cuando el tratamiento utilizado, junto con la dieta y el ejercicio, no logran un adecuado control glucémico y que sean pacientes con sobrepeso cuyo IMC sea igual o mayor a 30Kg/m ² que no hayan alcanzado un control glucémico adecuado con las dosis máximas toleradas de los otros hipoglucemiantes.	
A10BJ06	Semaglutida	0,25 mg 0,5 mg 1 mg	Tratamiento de la DM2 en obesos con un IMC igual o mayor de 30Kg/m ² y en terapia combinada con otros antidiabéticos (no en monoterapia), incluyendo insulina, cuando éstos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado.	
Antidiabéticos de administración diaria				
A10AE06	Insulina degludec	La dosis inicial diaria recomendada es de 10 unidades, seguida de ajustes individuales.	Su uso se restringe al tratamiento de pacientes diabéticos tipo 1 y 2 tratados con insulinas y análogos de insulina de acción prolongada que necesitan dos inyecciones basales diarias y que se caracterizan por riesgo relativamente alto de sufrir hipoglucemias.	Se requiere tratamiento previo con otras insulinas.
A10BJ01	Exenatida	5 µg/12 h 10 µg/12 h	Byetta está indicado para el tratamiento de DM2 en combinación con: - metformina - sulfonilureas - tiazolidindionas - metformina y una sulfonilurea - metformina y una tiazolidindiona en pacientes con sobrepeso cuyo IMC sea igual o mayor a 30Kg/m ² , que no hayan alcanzado un control glucémico adecuado con las dosis máximas toleradas de estos tratamientos orales. Byetta está también indicado como tratamiento coadyuvante a insulina basal con o sin metformina y/o pioglitazona en pacientes adultos con sobrepeso cuyo IMC sea igual o mayor a 30Kg/m ² que no hayan alcanzado un adecuado control glucémico con estos medicamentos.	Se requiere cálculo previo del IMC.

A10BJ02	Liraglutida	0,6-1,2-1,8 mg/24 h	Victoza está indicada en pacientes con sobrepeso con IMC igual o mayor a 30Kg/m ² que reúnan las indicaciones terapéuticas autorizadas del tratamiento de adultos, adolescentes y niños a partir de 10 años de edad con DM2 para alcanzar el control glucémico en combinación con medicamentos hipoglucemiantes orales y/o insulina basal cuando éstos, junto con dieta y ejercicio, no logran un control glucémico adecuado.	Se requiere cálculo previo del IMC.
A10BJ03	Lixisenatida	10 mg/24 h 20 mg/24 h	Está indicado en el tratamiento de la DM2 en adultos para alcanzar el control glucémico, en combinación con medicamentos hipoglucemiantes y/o insulina basal cuando éstos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado y restringido para aquellos pacientes con IMC mayor que 30Kg/m ² (ver secciones 4.2, 4.4 y 5.1 de la ficha técnica, sobre los datos disponibles para las diferentes combinaciones).	Se requiere cálculo previo del IMC.

Abreviatura utilizada: IMC: índice de masa corporal.

2. INFORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA PROCEDER AL VISADO

Sin esta información el operador de visado no tiene capacidad de poder autorizar/denegar dicho visado. Se necesitarán los siguientes datos, como en el siguiente *ejemplo de OZEMPIC (SEMAGLUTIDA) 0,25 MG PLUMA PRECARGADA:*

Juicio clínico (corresponde a diagnóstico principal): diabetes mellitus tipo 2 (DM2)

Indicaciones (corresponde a indicación principal): paciente con DM2 e IMC= 48Kg/m² en tratamiento con metformina 1000 mg/12 h.
Aclaramiento de creatinina de 90 ml/min.

Por motivos de seguridad del paciente, se recomienda aportar el valor del aclaramiento de creatinina.

Código CIE-9: 250.02

Diagnóstico: DIABETES MELLITUS TIPO 2 DESCONTROLADA

3. RECOMENDACIONES EN INSUFICIENCIA RENAL

Ajuste de dosis en insuficiencia renal según tasas de filtrado glomerular (ml/min/1,73 m ²)							
		LEVE		MODERADA		GRAVE	TERMINAL
		1 FG ≥ 90 (Dosis inicial)	2 FG ≥ 60 - 89	3a FG ≥ 45 - 59	3b FG ≥ 30 - 44	4 FG ≥ 15 - 29	5 FG < 15
BIGUANIDA	METFORMINA	500 - 850 mg/8-12 h	No ajuste*	Inicio: 500-850 mg/24h. Dosis diaria máxima total: 2000 mg. Evitar si función renal no es estable. Control cada 3-6 meses	No iniciar tratamiento. Puede continuarse. Ajuste de dosis al 50% Inicio 500-850 mg/día. Dosis diaria máxima total: 1000 mg. Evitar si función renal no es estable. Control cada 3 meses	No recomendada	No recomendada
SULFONILUREA	GLIMEPIRIDA	1 mg/24 h	No ajuste*	No recomendada**	No recomendada**	No recomendada	No recomendada
GLITAZONA	PIOGLITAZONA	15 - 30 mg/24 h	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No recomendada
IDPP4	LINAGLIPTINA	5 mg/24 h	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*
arGLP1	SEMAGLUTIDA	Dosis inicial: 0,25 mg/semana SC. Dosis máxima: 0,5 - 1 mg/semana	No ajuste* Dosis máxima 0,5 mg/semana	No ajuste* Dosis máxima 0,5 mg/semana	No ajuste* Dosis máxima 0,5 mg/semana	Experiencia limitada	No recomendada
	EXENATIDA	5 µg/12 h SC	No ajuste*	No ajuste*	Experiencia limitada. Proceder cuidadosamente en el escalado de la dosis de 5 µg a 10 µg	No recomendada	No recomendada
	EXENATIDA LAR	2 mg/semana SC	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No recomendada	No recomendada
	LIRAGLUTIDA	0,6 mg/24 h SC	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No recomendada	No recomendada
	LIXISENTATIDA	10 µg/24 h SC	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No recomendada	No recomendada
ISGLT2	DULAGLUTIDA	0,75 mg/semana SC	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No recomendada. Experiencia muy limitada
	CANAGLIFLOZINA	100 mg/24 h	No ajuste* Se puede aumentar hasta 300 mg si se requiere un control adicional de la glucemia.	Iniciar con 100 mg. Continuar con 100 mg en pacientes que ya estén tomando canagliflozina.	Iniciar con 100 mg. Continuar con 100 mg en pacientes que ya estén tomando canagliflozina.	No iniciar. Continuar con 100 mg en pacientes que ya estén tomando canagliflozina.	No recomendada
	EMPAGLIFLOZINA	10 mg/24 h	No ajuste*	No ajuste*	No ajuste*	No recomendada en FG<30*	No recomendada
INSULINA			No ajuste*		FG 50-10 ml/min/1,73 m ² : reducción 25% de la dosis		FG < 10 ml/min/1,73 m ² : reducción 50% de la dosis

a Para tratar la insuficiencia cardíaca puede usarse hasta FG<20 ml/min

*No ajustes adicionales por ERC: ajustar según glucemia y objetivo de HbA1c.

**Datos extraídos de: Gómez-Huelgas, Ricardo, et al. "Documento de Consenso sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 en el paciente con enfermedad renal crónica". Nefrología (Madrid)34.1 (2014): 34-45.

Tabla modificada del documento "Recomendaciones para la selección del tratamiento farmacológico en Diabetes Mellitus tipo 2". Grupo de trabajo Uso Adecuado del Medicamento en Diabetes. Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. Servicio Andaluz de Salud.

Fuentes consultadas:

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sobre gestión y control del visado de recetas. BOJA nº 245 de 23/12/2021. <https://juntadeandalucia.es/boja/2021/245/39>

Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos. BOE nº 114 de 12/05/2007.

Informe de posicionamiento terapéutico de la canagliflozina 300 mg, canagliflozina/metformina, dulaglutida, linagliptina y semaglutida. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Disponibles en: <https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/informes-de-posicionamiento-terapeutico/>

Ficha técnica de los medicamentos incluidos. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Disponibles en: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>

Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos: BIFIMED. <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do>